

総論

抗がん剤の分類と作用機序

分類・副作用の評価

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬

DNA合成・細胞分裂を障害

アルキル化薬・白金製剤

シクロホスファミド

シスプラチン

オキサリプラチン

代謝拮抗薬

5-FU

S-1

カペシタビン

ゲムシタビン

微小管・トポ阻害薬ほか

パクリタキセル

イリノテカン

ドキシソルビン

分子標的薬

がん特徴的な分子を狙う

小分子薬(経口)

イマチニブ

オシメルチニブ

レンバチニブ

抗体薬

トラスツズマブ

ペバシズマブ

セツキシマブ

抗体薬物複合体(ADC)

T-DXd

T-DM1

免疫チェックポイント阻害薬

T細胞のブレーキを解除

抗PD-1抗体

ニボルマブ

ペムブロリズマブ

抗PD-L1抗体

アテゾリズマブ

デュルバルマブ

抗CTLA-4抗体

イビリムマブ

ホルモン療法

ホルモンの作用を遮断

乳がん

タモキシフェン

アナストロゾール

レトロゾール

フルベストラント

前立腺がん

エンザルタミド

アピラテロン

リュープロレリン

経口薬(保険薬局で交付されることが多い)

注射薬

2 分類ごとの特徴と薬局での関わり

細胞障害性抗がん薬	分子標的薬	免疫チェックポイント阻害薬	ホルモン療法
標的 分裂の速い細胞(非選択的) 主な副作用 骨髄抑制・悪心嘔吐・脱毛・口内炎 起こる時期 投与後の決まった時期(nadir等)	標的 がん特徴的な分子 主な副作用 標的に応じた特有の副作用(皮疹・高血圧・下痢・ILD等) 起こる時期 服用開始から継続的に	標的 免疫のブレーキ(PD-1等) 主な副作用 irAE(皮膚・消化管・内分泌・肺など全身) 起こる時期 数週～数か月、終了後も	標的 ホルモン受容体・産生 主な副作用 ほてり・関節痛・骨密度低下・血栓症 起こる時期 年単位の長期服用
保険薬局での主な関わり 経口薬の服用日管理、nadir期の電話フォロー	保険薬局での主な関わり 相互作用・服用時点の確認、スキンケア指導	保険薬局での主な関わり 投与歴の把握、体調変化の聴取と受診勧奨	保険薬局での主な関わり アドヒアランス支援、骨・血栓の確認

3 副作用の特徴と発現時期

	投与日	1週	2週	1か月	3か月	1年～
● 過敏症(抗体薬・タキサン)	● 投与中～24時間					
● 悪心・嘔吐(細胞障害性)	● ～5日					
● 好中球減少(細胞障害性)		● 7～14日目				
● 皮疹・下痢(EGFR阻害薬)		● 服用1～2週から				
● 高血圧・蛋白尿(血管新生阻害薬)		● 開始数週				
● irAE(免疫チェックポイント阻害薬)			● 数週～数か月、終了後も			
● 間質性肺疾患			● 時期を問わず起こりうる			
● 関節痛・骨密度低下(ホルモン療法)					● 数か月～年単位	

☒ 重篤・特に注意
 ☐ その他

押さえておきたいポイント

1. 抗がん剤は4分類(細胞障害性・分子標的・ICI・ホルモン)。分類ごとに副作用の種類も時期も異なる
2. 副作用はCTCAEのGradeで評価し、Gradeに応じてセルフケア支援・処方医への連絡・受診勧奨を判断
3. 病院はレジメン監査と投与、薬局は経口薬の管理と自宅での経過確認。情報共有が安全な治療の鍵